

Taquicardias Ventriculares: Diagnósticos Diferenciais

Quando nos deparamos com uma **taquiarritmia de QRS largo** (maior que 120 ms), precisamos entender um dado estatístico fundamental: em aproximadamente **80% dos casos**, estamos diante de uma verdadeira **taquicardia ventricular** - ou seja, uma arritmia que se origina abaixo do nó atrioventricular, nos ventrículos. No entanto, os outros **20% dos casos** representam um desafio diagnóstico interessante, pois correspondem ao que chamamos de **taquicardia supraventricular com condução aberrante**.

Mas o que significa exatamente essa condução aberrante? Trata-se de uma situação em que a arritmia é genuinamente supraventricular - portanto, deveria apresentar um QRS estreito - porém o paciente já possui previamente um **bloqueio de ramo direito** ou um **bloqueio de ramo esquerdo**. Vale a pena refletir sobre a lógica desse fenômeno: se determinado paciente já tem o QRS alargado em condições basais devido a um distúrbio de condução intraventricular prévio, não há razão para que esse QRS se estreite magicamente durante um episódio arritmico. O bloqueio de ramo continuará presente, independentemente da taquicardia, resultando em um QRS largo mesmo que a origem da arritmia seja supraventricular.

Exemplo clínico: Imagine um paciente de 65 anos, portador de doença de Chagas, que já apresenta bloqueio completo de ramo direito no ECG basal. Quando esse paciente desenvolve uma fibrilação atrial com resposta ventricular rápida, o traçado eletrocardiográfico mostrará taquicardia de QRS largo - mas a origem é supraventricular, não ventricular.

A questão que naturalmente surge é: como diferenciar essas duas situações na prática? Como distinguir uma taquicardia supraventricular com aberrância de uma taquicardia ventricular genuína? Para responder a essa pergunta, foram desenvolvidos diversos **critérios diagnósticos**, sendo os mais conhecidos os

critérios de Brugada, Vereckei, Pava e critérios dos Santos. Embora não seja necessário decorar todos os detalhes desses critérios - afinal, são ferramentas mais voltadas para o especialista em arritmias - é fundamental conhecer sua existência, pois questões teóricas de concursos médicos frequentemente cobram qual critério deve ser utilizado nessa diferenciação.

Vamos explorar os dois critérios mais importantes: Brugada e Vereckei.

Os **critérios de Brugada** funcionam como um algoritmo sequencial, um verdadeiro passo a passo diagnóstico. A abordagem prática consiste em posicionar o eletrocardiograma do paciente de um lado e o fluxograma dos critérios do outro, respondendo sistematicamente a cada pergunta. A primeira pergunta é: **existe ausência de complexo RS nas derivações precordiais?** Se a resposta for sim, o diagnóstico é taquicardia ventricular e a avaliação termina aqui. Se a resposta for não, avançamos para a próxima etapa do algoritmo.

A segunda pergunta investiga se há **intervalo RS maior que 100 ms em alguma derivação precordial**. Caso positivo, temos uma taquicardia ventricular. Caso negativo, prosseguimos para a terceira etapa, que busca identificar a presença de **dissociação atrioventricular**. Se identificarmos a dissociação AV, o diagnóstico é TV. Se não houver dissociação, partimos para a análise de **critérios morfológicos específicos**, que são bastante detalhados e técnicos. Caso os critérios morfológicos sugiram TV, fechamos esse diagnóstico. Por outro lado, se o paciente responder negativamente a todas as etapas do algoritmo, concluímos tratar-se de uma taquicardia supraventricular com condução aberrante.

O segundo critério que merece destaque é o **critério de Vereckei**, que possui uma característica distintiva: utiliza principalmente a **derivação aVR** como ferramenta diagnóstica. A primeira pergunta desse algoritmo é extremamente objetiva: **existe uma onda R inicial na derivação aVR?** Se a resposta for sim, o diagnóstico de taquicardia ventricular está estabelecido de forma definitiva - não é necessário avançar no algoritmo. A presença de onda R inicial em aVR funciona como um critério diagnóstico isolado suficiente para TV. Caso essa onda R inicial não esteja presente, seguimos descendo o fluxograma do critério de Vereckei, respondendo às

perguntas específicas subsequentes de forma análoga ao que fizemos com Brugada.

Mnemônico prático: "R em aVR = Ritmo Ventricular" - um jeito simples de lembrar que onda R inicial em aVR fecha o diagnóstico de TV.

Agora vem o ponto mais importante de toda essa discussão, e que está explicitamente estabelecido nas **diretrizes cardiológicas**: na dúvida entre taquicardia ventricular e taquicardia supraventricular com aberrância, a conduta recomendada é **sempre tratar como taquicardia ventricular**. Essa orientação não é arbitrária - ela se baseia em princípios de segurança do paciente, pois uma TV não tratada adequadamente pode evoluir para fibrilação ventricular e morte súbita. Portanto, você está completamente respaldado em tomar essa decisão terapêutica mesmo quando os critérios diagnósticos não estão completamente claros ou quando você não consegue aplicar o algoritmo com precisão.

Comentário crítico: Essa regra de ouro - "na dúvida, trate como TV" - reflete um princípio fundamental da medicina de emergência: é preferível tratar de forma mais agressiva uma arritmia potencialmente benigna do que subestimar uma arritmia potencialmente letal. As consequências de não tratar adequadamente uma TV verdadeira são muito mais graves do que tratar de forma mais intensiva uma TSV com aberrância.

Em síntese, o diagnóstico diferencial entre taquicardia ventricular e taquicardia supraventricular com condução aberrante representa um desafio clínico relevante, mas existem ferramentas diagnósticas validadas (como os critérios de Brugada e Verecke) para auxiliar nessa distinção. Mais importante ainda, as diretrizes nos fornecem uma orientação clara e segura para situações de incerteza diagnóstica: conduza o caso como taquicardia ventricular e você estará protegendo adequadamente seu paciente.